جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : دريه احمد ابو سريع حماد
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** حلوان **العنوان :** مممممممممممم
رقم البطاقة : 27107290103763 **رقم التليفون :** 01129441315 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 29-07-1971 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: دريه احمد ابو سريع حماد
National ID: 27107290103763

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

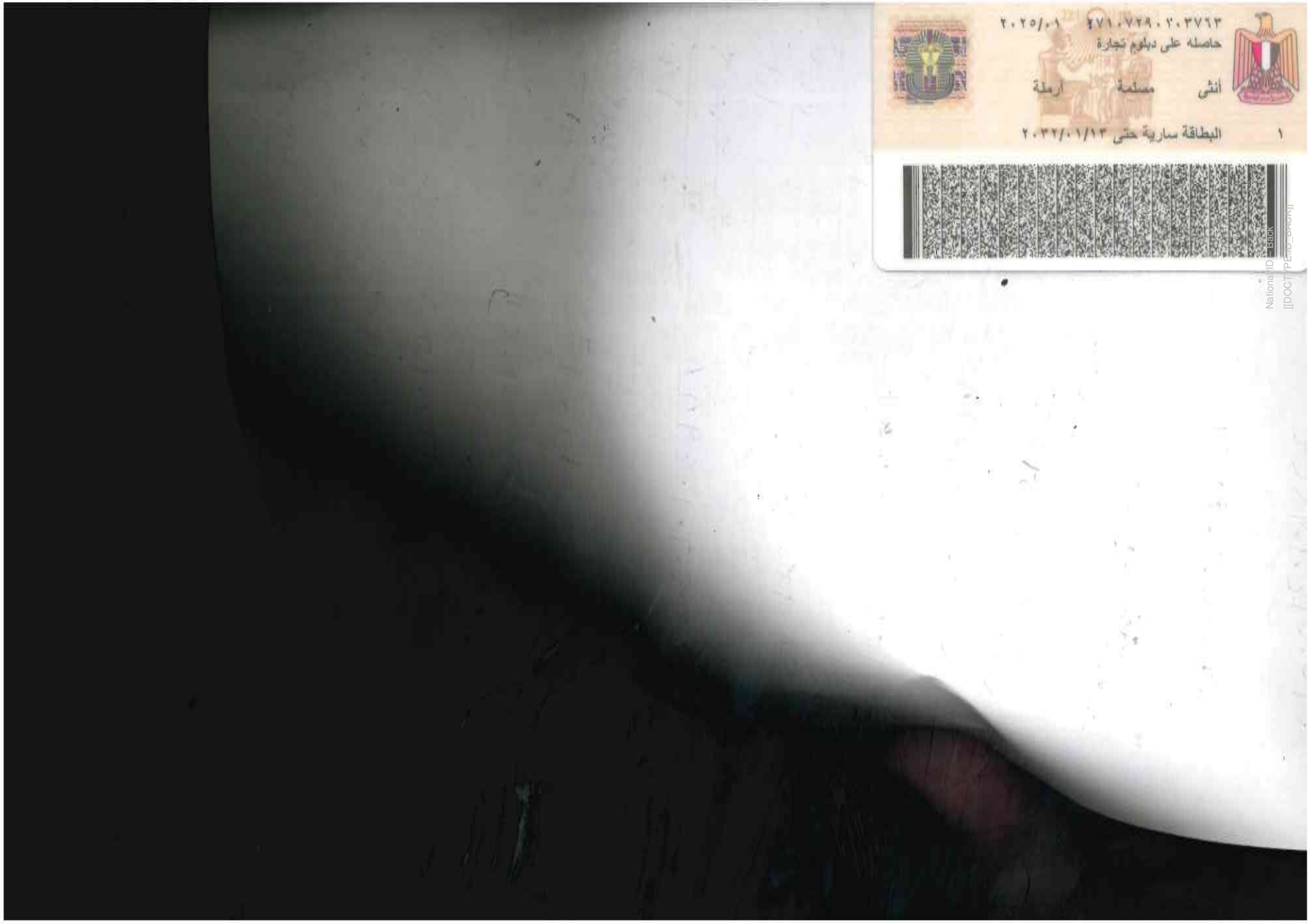
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
دريه
احمد ابوسريع عبده
٢٠بلوك٦-مجاورة ٤-المشروع الامريكى
حلوان - القاهره
٢٧١٠٧٢٩٠١٠٣٧٦٣
KY3037263


٢٧١٠٧٢٩٠٢٠٣٧٦٣
٢٠٢٥/٠١
حاصله على دبلوم تجارة
أنثى
مسلمة
أرملة
١
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠١/١٣
National ID - 350K
[[DOCTYPE_PHOTO_CARD]]

[[DOCTYPE:NON_HIO_LETTER]]

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECION SUPPORT

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

جهه الاصدار :فرع القاهرة

تاريخ الاصدار :2023-4-30

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) دريه احمد ابو سريع بطاقة رقم 27107290103763/

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع

يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون اى مسئولية على الهيئة العامة للتامين الصحى من خضوع المواطن لقانون التأمين الضحى الشامل

وشكرا

الموظف المختص
منى حسين

تاريخ الطباعة :2023-4-30

مسلسل 651165

الخطاب ساري لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاصدار الا في حالة تغيير المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية

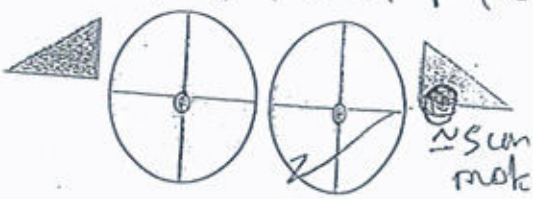
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM

Name	[illegible]
Age	56 yrs old.
MRN	
ID	
Co morbidity	

[illegible]



Clinical Data

Bx:
Lt. Axilla LN Poorly differentiated Carcinoma

SM:
Lt. Axilla LN (3x1.8cm)

IHC:
ER: +ve (7/8)
PR: +ve (7/8)
Her2: +ve (+3)
KI67:

Mets Workup:
CTs → NAD

$T_x N_2 M$

COMMENT:

for Possibility of NACT.

MRI breast → Axilla LNs only (occult Lt Axilla LN of Primary origin)

MDT OUTCOME & PLAN

31-7-2021 → Revise Pathology → Primary origin?? (GATA3 +ve)

1st Re-asses – echo, Bone scan ??

by Bilat US

If lesion

Bx-Re

2) NAT (4 AC – 4 Taxanes/Herceptin/pertuzumab)

Then Lt MRM.

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
SIGNATURE			

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

مستشفى أورام دار السلام
قسم الباثولوجى

Pathology Report

Name: دريه احمد ابوسريع حماد Age: 50 years.

Clinical data: Left axillary Lymph node.

Specimen type: Tru -cut biopsy.

Date (Received):20 /4/2021 Date(reported): 12/7/2021(IPT)

Lab. Number:863 /21(final) Hospital Number: صحة المرأة

Gross Description:

Four greyish white tissue cores 1cm, each, totally submitted.
Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,
ER clone (1E2).
PR clone (SP1). Additional submitted material 4 referred slides labeled by the patient name and one block (12-7-2021).

Microscopic examination:

Sections examined from the specimen received revealed cores of nodal tissue showing infiltration by an infiltrating malignant epithelial growth, made up of groups and small sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant epithelial cells.

- Examination of ER stained slide show moderate nuclear stain in 80% of the tumor cells.
- Examination of PR stained slide show moderate nuclear stain in 80%% of the tumor cells.
- Examination of GATA3 stained slide show positive staining of the tumor cells.
- Examination of Her2 stained slide show strong complete membranous staining in 30% of the tumor cells

Diagnosis:

Left axillary Lymph node, Tru -cut biopsy:

- **Metastatic poorly differentiated carcinoma for metastatic work up.**
- **ER: Positive (score 7/8)**
- **PR: Positive (score 7/8)**
- **GATA3 : Positive.**
- **Her2 : Positive (score 3+)**

Comment :

Localization of breast primary by breast MRI findings and exclusion of other primary tumor by metastatic workup is recommended.

Prof. Dr. Iman Gouda.
Prof. Dr. Amal Hareedy.
Dr. Mona Mohamed.

اورام دار السلام

Pathology Report

Name: دريه احمد ابوسريع حماد Age: 50 years.

Clinical data: Left axillary Lymph node.

Specimen type: Tru -cut biopsy.

Date (Received):20 /4/2021 Date(reported): /4/2021

Lab. Number:863 /21 Hospital Number: صحة المراة

Gross Description:

Four greyish white tissue cores 1cm, each, totally submitted.

Microscopic examination:

Sections examined from the specimen received revealed cores of nodal tissue showing infiltration by an infiltrating malignant epithelial growth, made up of groups and small sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant epithelial cells .

Diagnosis:

Left axillary Lymph node, Tru -cut biopsy;
Metastatic poorly differentiated carcinoma for metastatic work up and immunostaining (CK7, CK20, GCDFP15, ER , PR)
ER: Positive, score (7/8)
PR: Positive, score (7/8)

Prof. Dr. Amal Hareedy
Dr.Marwa Mahmoud
Dr.Mona Mohamed

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

National Women's Health Initiative
Pathology Lab
معمل باثولوجي المبادرة القومية لصحة المرأة

Pathology Report

Name: دريه احمد ابو سريع حماد Age: 51 years.

Clinical data: Lt breast asymmetry &Lt pathologic axillary LN.

Specimen type: Tru cut

Date (Received):4 /8/2021. Date(reported): 7/8/2021

Lab. Number: 1676 / 21 Hospital Number: صحة مراه

Gross Examination:

- Procedure: two specimens: 1) Lt breast: five core fragments up to 0.2cm. totally submitted.
  2) Lt axillary lymph node: two cores totally submitted
- Immunohistochemistry technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2. ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 CLONE (4B5), & Ki67 (30-9)

Microscopic examination:

1) Scanty breast tissue showed few glands lined by hyperplastic crushed cells.
2) Lymphoid core showed metastatic groups of atypical large epithelial cells having large hyperchromatic nuclei.

Diagnosis:

Lt breast asymmetry &Lt pathologic axillary LN, tru-cut biopsy:

1) Breast tissue, no malignancy, another biopsy is recommended if malignancy is suspected.
2) Metastatic carcinoma GII in lymph node, for (ER, PR, Her2 &ki67)

- Biomarkers (done on biopsy 2):
  - ER: strong nuclear reaction, in 70% of tumor cells (Allred score 0/8)
  - PR: moderate Intensity 15% nuclear reaction (Allred score 4/8)
  - Her2: strong complete membranous staining in 10% of tumor cells (score 3+)
  - Ki67: 25% nuclear reaction

Prof. Amal Hareedy
Dr. Rania Fathy

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

قسم الاشعة التشخيصية

PATIENT NAME: DORAYAH AHMED ABOSEREA HAMAD GENDER: Female AGE: 49 y	PATIENT ID #: 2021157513 ORDER #: 1136646,1136647 DATE OF SERVICE: 10-Jul-2021 01:38 PM

Report: - all studies

CONTRAST ENHANCED MSCT OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

I- CHEST FINDINGS:

- Enlarged left axillary lymph nodes are seen (levels I and II) - the largest measures about 28 x 38 mm in its maximum axial dimensions.
- Enlarged left internal mammary lymph node is seen measuring about 10 x 7.5 mm.
- ***Right lower lobar peripheral subcentimetric solid nodules (??significance).***
- Right upper lobar parenchymal band.
- No pulmonary masses, consolidation, collapse or cavitary lesions.
- No pathologically enlarged mediastinal or hilar lymph nodes.
- ***Borderline cardiac size.***
- No pleural or pericardial collections.

(II) ABDOMEN AND PELVIS FINDINGS:

- Enlarged liver (span =20.5 cm) showing smooth outlines and homogeneous parenchymal attenuation. No definite focal lesions or dilated biliary radicles.
- Patent homogeneously opacified portal vein and its main branches.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Distended urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- Normal CT appearance of rest of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No ascites.

OPINION:

- **Left axillary and internal mammary lymphadenopathy**
- **Hepatomegaly**

Reported By,

Dr. Eman Zaky, MD
Dr. Ahmed Abdelmoneim, MSc **10-Jul-2021 05:27 PM**

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient Name	: الأستاذه / دريه احمد ابو سريع	Request No.	: 13003013
Patient No.	: 27107290103763	Request Date	: 24/03/2022
Path No.	: 826/2022	Verification Date	: 31/03/2022
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 50 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

(Amended Report)

CLINICAL DATA:
Known case of left breast occult cancer, with positive axillary lymph nodes deposits, Post chemotherapy.

NATURE OF SPECIMEN:
Left Axillary nodes clearance, collected at 23/3/2022, 12.00Pm

GROSS PATHOLOGY:
Fibrofatty tissue pieces 18x10x4 cm collectively, enclosing 13 nodules up to 2x1 cm.

HISTOPATHOLOGY:
Histopathologic examination of dissected nodes revealed 8 fibrosed nodes from 13 dissected nodes with NO viable tumor deposits (Therapy effect).

DIAGNOSIS:
Known case of left breast occult cancer , with positive axillary lymph nodes deposits (Post NACT); Left Axillary nodes clearance:
- No Viable tumor tissue. LNs (0/13).
- Stage: ypN0.

Signature
Prof. Dr. Aml Hareedy
Dr. Marwa Mahmoud
Dr. Walaa Ghonaim

Verified by :
walaa ghoniem

Nasr City - Cairo - Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

PATIENT NAME: DORAYAH AHMED ABOSEREA HAMAD	PATIENT ID #: 2021157513
GENDER: Female	ORDER #: 1136645
AGE: 50 y	DATE OF SERVICE: 01-Aug-2021 01:39 PM

Report:

99mTc-MDP BONE SCAN

Desired Information :- skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 minutes & 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99mTc-MDP :

Findings:-

Degenerative changes at dorso-lumbar vertebrae, more advanced at lumbar region for follow up.

Arthritic changes at knees and shoulders.

Other wise, the rest of surveyed skeleton is free from definite serious lesions.

Both kidneys are seen.

Conclusion:-

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Reported By,

Ass. Prof. Huda Fathy Elsayed **01-Aug-2021 04:33 PM**